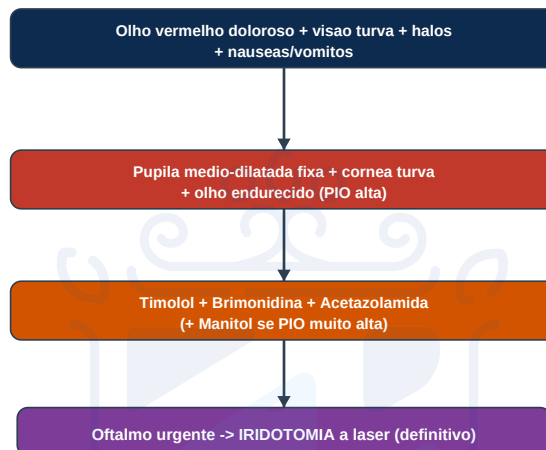


GLAUCOMA AGUDO DE ÂNGULO FECHADO

FLUXOGRAMA — BAIXAR A PIO JÁ

GLAUCOMA AGUDO — TEMPO É VISÃO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Elevação súbita e acentuada da PIO por contato iridotrabecular completo (fechamento do ângulo)
- EMERGÊNCIA oftalmológica — pode causar cegueira irreversível rapidamente
- Diferente do glaucoma crônico (neuropatia óptica progressiva, assintomática por anos)
- O bloqueio pupilar impede a drenagem do humor aquoso -> PIO dispara

QUADRO CLÍNICO E FATORES DE RISCO

RECONHECER

- Dor ocular intensa unilateral + visão turva súbita + halos coloridos ao redor de luzes
- Cefaleia + náuseas e vômitos (podem simular abdome agudo!) + fotofobia + olho vermelho
- Fatores de risco: hipermetropia (olho curto), idade avançada, sexo feminino, descendência asiática
- Gatilhos: ambiente escuro (midríase), medicações midríáticas (anticolinérgicos, simpaticomiméticos, TOPIRAMATO)
- Episódios prévios autolimitados (subagudos) são pista importante

EXAME FÍSICO

ACHADOS-CHAVE

- Hiperemia conjuntival/episcleral acentuada (injeção ciliar) — comparar com o olho contralateral
- Córnea edemaciada (nebulosa/turva)
- Pupila MÉDIO-DILATADA (4-6 mm) e NÃO reativa à luz
- Câmara anterior rasa; PIO muito elevada (> 30-40 mmHg)
- Palpação digital pelas pálpebras fechadas: olho afetado MUITO mais endurecido que o contralateral

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO (EMERGÊNCIA)

Rx BAIXAR A PIO — INICIAR JÁ

Timolol 0,5% colírio — 1 gota no olho afetado imediatamente (betabloqueador)
Brimonidina 0,2% colírio — 1 gota (agonista alfa-2; usar se CI ao timolol)
Acetazolamida 500mg EV em ataque (ou 250-500mg VO se EV indisponível) — inibidor da anidrase carbônica
Manitol 20% 1-2 g/kg EV em 30-60 min — se PIO muito elevada ou resposta inadequada
Suporte: antiemético (metoclopramida 10mg EV / ondansetrona) + analgesia (dipirona 1g EV)

PILOCARPINA — ATENÇÃO À ARMADILHA

MIÓTICO SÓ APÓS PIO < 40 mmHg

- Pilocarpina 1-2% 1 gota de hora em hora nas 3 primeiras horas — SOMENTE quando PIO < 40 mmHg
- Com PIO muito alta, há isquemia do esfíncter pupilar -> a pupila NÃO responde ao miótico
- CONTRAINDICADA se a causa for topiramato (mecanismo diferente — não é bloqueio pupilar)
- A redução farmacológica é ponte para o tratamento definitivo, não substitui a iridotomia

TRATAMENTO DEFINITIVO

RESOLVER O BLOQUEIO

- Iridotomia periférica a laser (LPI) — tratamento de ESCOLHA; assim que a PIO cair e a córnea clarear
- Profilaxia no olho contralateral é recomendada (risco bilateral)
- Alternativas: paracentese de câmara anterior, iridoplastia a laser, iridectomia cirúrgica, facoemulsificação se catarata
- Gonioscopia é o padrão-ouro diagnóstico (realizada pelo oftalmologista)

INTERNAÇÃO x ALTA

Decisão	Critérios
Internar	PIO não controlada; impossibilidade de LPI imediata; vômitos incoercíveis; necessidade de paracentese/cirurgia; sem seguimento em 24h
Alta	PIO controlada (<21-25 mmHg); LPI realizada; sintomas controlados; córnea clareando; seguimento oftalmológico garantido em 24-48h

CHECKLIST NO PS

NÃO ESQUECER

- ☐ Reconhecer: olho vermelho doloroso + náuseas/vômitos NÃO é abdome agudo nem enxaqueca banal
- ☐ Iniciar redução da PIO imediatamente (não aguardar oftalmo para começar)
- ☐ Suspender/Evitar midriáticos e anticolinérgicos
- ☐ Antiemético e analgesia para permitir cooperação
- ☐ Acionar oftalmologista de urgência para iridotomia

MODELO DE REGULAÇÃO — URGÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Glaucoma agudo de ângulo fechado em OD/OE há ____; dor intensa, halos, visão turva + náuseas/vômitos.
- Exame: córnea turva, pupila médio-dilatada fixa, olho endurecido à palpação. PIO: ____.
- Tratamento no PS: timolol + brimonidina + acetazolamida (+ manitol/pilocarpina se aplicável) + antiemético/analgesia.
- Necessita URGENTE de iridotomia periférica a laser — risco de cegueira irreversível.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente idosa com dor ocular intensa unilateral, halos coloridos, visão turva, náuseas e vômitos. Ao exame: córnea turva, pupila médio-dilatada fixa, olho endurecido. Diagnóstico?

- A) Conjuntivite viral
- B) Glaucoma agudo de ângulo fechado
- C) Enxaqueca com aura
- D) Uveíte anterior leve
- E) Episclerite

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento DEFINITIVO do glaucoma agudo de ângulo fechado por bloqueio pupilar?

- A) Timolol tópico contínuo
- B) Acetazolamida oral por tempo indeterminado
- C) Iridotomia periférica a laser
- D) Corticoide sistêmico
- E) Apenas manitol endovenoso

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que a pilocarpina só deve ser usada após a PIO cair abaixo de 40 mmHg?

- A) Porque acima disso causa midríase paradoxal
- B) Porque com PIO muito alta há isquemia do esfíncter pupilar e a pupila não responde ao miótico
- C) Porque a pilocarpina eleva ainda mais a PIO
- D) Porque só age na conjuntiva
- E) Porque provoca descolamento de retina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual fator de risco anatômico está classicamente associado ao glaucoma agudo de ângulo fechado?

- A) Miopia alta (olho longo)
- B) Hipermetropia (olho curto, câmara anterior rasa)
- C) Astigmatismo isolado
- D) Presbiopia
- E) Daltonismo

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o manejo inicial no PS do glaucoma agudo, assinale a correta:

- A) Deve-se aguardar o oftalmologista antes de qualquer medicação
- B) Iniciar imediatamente a redução da PIO (timolol, brimonidina, acetazolamida +/- manitol) e acionar oftalmo urgente
- C) Dilatar a pupila com tropicamida
- D) Prescrever apenas analgésico e alta
- E) Aplicar corticoide tópico como primeira medida

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A tríade olho vermelho doloroso + halos/visão turva + náuseas/vômitos, com córnea turva, pupila médio-dilatada fixa e olho endurecido, é típica do glaucoma agudo de ângulo fechado — emergência cegante.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

O tratamento definitivo é a iridotomia periférica a laser, que alivia o bloqueio pupilar criando uma comunicação na íris. As medicações apenas baixam a PIO como ponte. Profilaxia no olho contralateral é recomendada.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Com PIO muito elevada (>40), o esfíncter pupilar fica isquêmico e não responde ao miótico — a pilocarpina seria ineficaz. Por isso, usa-se só após reduzir a PIO. É contraindicada se a causa for topiramato.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipermetropia (olho axialmente curto, com câmara anterior rasa e ângulo estreito) é o fator anatômico clássico. Miopia (olho longo) é fator protetor para o fechamento angular.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O manejo inicial não deve esperar o especialista: inicia-se imediatamente a redução da PIO (timolol, brimonidina, acetazolamida, manitol se necessário) com antiemético/analgesia, acionando oftalmo de urgência. Jamais dilatar a pupila.

SM24
Suporte ao Plantão Médico